

JOAO BASTISTA DE SIQUEIRA	
MEDICAMENTOS:	↑ de Hemácias (AAS)
SINTOMAS/QUEIXAS	
HORA QUE DORME	
HORA QUE ACORDA	IAH = 53.8 e/h
SONECA DURANTE O DIA	
HORARIO DAS REFEIÇÕES	
CAFE:	ALMOÇO: LANCHE: JANTA:
07/04	Poa bem adaptando leu, ajuste o CPAP.
22	P = 10.2 / cmH ₂ O
18/04	IAH = 8.4 / ev
22	M. de uso: 5h 54'
	Bem adaptando, refere dificuldade p/ expirar
03/05	P = 9.9
22	IAH = 7.0
	M. de uso: 8h 11'
03	P = 9.8
06	IAH = 8.9
22	M. de uso: 8h 20'
03/07	P = 9.8 cmH ₂ O
22	IAH = 8.3 / ev
	M. de uso: 6h 30'
	Fuga = 2.1
	Bem adapt. + Biologin
29/09	P = 9.8 cmH ₂ O
22	IAH = 10.5 / ev
	M. de uso: 6h 14'
28/11	P = 9.8 cmH ₂ O
22	M. de uso: 7h 28'
	IAH = 8.6 e/ev
	Fuga = 16.8 l/min
27/03	P = 9.8 cmH ₂ O
2023	IAH = 9.4
	M. uso = 8 horas (total com soneca tarde)
	fuga = 19.2 (Ajusto máscara)
	↓ umidif. 4
29/05	P = 9.8 cmH ₂ O (central 6.1)
2023	IAH = 6.9
	M. de uso = 8h 30'
	fuga = 19.5 l/min
08/08	P = 9.8 cmH ₂ O
23	IAH = 4.3 e/ev
	M. de uso: 7h 36'
07/11	P = 9.8 cmH ₂ O
23	IAH = 3.2 e/ev
	M. de uso: 6h 4' (IC = 2.7 e/ev)
	Bem adapt., sí queixas - Aue

João Batista de Siqueira

20/04 P=9,8 cmH₂O
IAH=4,5 e/h (C:3,6 O:0,1 Der:0,2 IH:0,6)
m. de uso=7h38
fuga=43 l/min

P=9,8 cmH₂O
IAH=4,0 e/h
m. de uso=6h21'
Fuga=9,2 med. / porc. 95%=39,9.

João

10/04
24

P=9,8 cmH₂O
IAH=3,3 e/h

m. de uso: 5h13m

Fuga: 9,4 med / porc 95%, 37,3 Natália

28/07
24

P=9,8
IAH=6,8 e/h
m. de uso: 4:16h.
fuga=11,7 lpm

Bem adaptado, porém hemácias 4+ Jua

14/11
24

P=9,8
IAH=3,1 e/h
M. de uso: 3h20'

Encaminhei p/a fono.

Jua

25/02
25

P=9,8 cmH₂O
IAH=4,5 e/h
m. de uso: 4h23'
fuga: 30,3 l/min

Bem adaptado

Natália

11/06/25

P=9,8 cmH₂O
IAH=3,6 e/h
m. de uso=5h20 min
fuga=31 l/min

Bem adaptado; quando proleta amígdalas

heco filio

(espera retorno
ca mama)

Silvia

26/06/25 Relatório p/ colonoscopia — Jua

Nome: JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA

Data de Nascimento: 15-6-1962

IMC: 27,31

Sexo: Masculino

Data do exame: 11-02-2022

Peso: 78 kg

Altura: 1,69 m

Médico: DRA. CARLA CECILIA MULIN

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 11-02-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 501,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 127,5 e 103,0 minutos. O tempo total de sono foi de 264,5, eficiência de 52,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,6%; estágio N2: 69,4%; estágio N3: 12,3%; sono REM: 15,7%. O índice de despertares foi de 24,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 53,8/hora, sendo elas 22 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 34 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 84%, permanecendo 8,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 45 - 75 bpm e NREM de 42 - 76 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 53,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=84%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

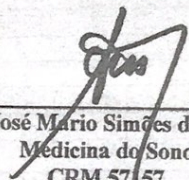
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157